



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
MUTU KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
RS PRIMA HUSADA MALANG**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

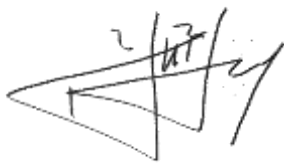
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 129.11/I-PND/DIR/II/2026

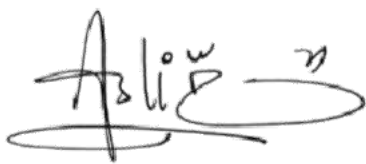
Tentang
Panduan Mutu Tenaga Kesehatan Lain

Disusun oleh :
Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain



Dinar Sahara, AMd. Fis

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Mutu Tenaga Kesehatan Lain dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan panduan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan mutu tenaga kesehatan lain ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 11 Februari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini, M.Kes
2. Dinar Sahara, AMd.Fis
3. Elzada Sofi Ananda, A.Md.Kes
4. Elis Wahyuni Amd.Ak
5. apt. Guspa Gayatri Azmi, S.Farm.
6. Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes
7. Isma Mufida AMd.Rad
8. Suci Nur Pratiwi S. Gz
9. Nabila Rizki Amalia, S.Tr, Kes
10. Noviantoro, AMd. FT
11. Salma Gita Pramesti, A.Md.T
12. Irwinda Neila Fitria, S.Tr.Kes

DAFTAR ISI

Sampuli

Halaman Pengesahanii

Kata Pengantariii

Tim Penyusun iv

Daftar Isi..... v

Lampiran 1

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 1

Bab I. Definisi 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan 1

 1.2.1 Tujuan Umum 1

 1.2.2 Tujuan Khusus..... 1

 1.3 Definisi 1

 1.4 Ruang Lingkup 2

Bab II. Tata Laksana 3

 2.1 Audit Tenaga Kesehatan Lain..... 3

 2.2 Merekomendasikan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Staf Tenaga Kesehatan Lain
 4

 2.3 Memfasilitasi Proses Pendampingan (Proctoring) Bagi Staf Tenaga Kesehatan
 Lain Yang Membutuhkan;..... 5

Bab III. Dokumentasi 6

Bab IV. Penutup 7

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 129.11/I-PND/DIR/II/2026
TENTANG PANDUAN MUTU TENAGA
KESEHATAN LAIN

PANDUAN MUTU TENAGA KESEHATAN LAIN

BAB I

DEFINISI

1.1 LATAR BELAKANG

- a. Setiap tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan penunjang wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.
- b. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan “Audit tenaga kesehatan lain”
- c. Pembinaan dan pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi.

1.2 TUJUAN

1.2.1 Tujuan Umum

- a. Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf tenaga kesehatan lain yang bermutu, kompeten, etis dan profesional.
- b. Memberikan asas keadilan bagi staf tenaga kesehatan lain untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi (maintaining competence) dan kewenangan klinis (clinical privilege).
- c. Mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (medical mishaps)
- d. Memastikan kualitas asuhan tenaga kesehatan lain yang diberikan oleh staf tenaga kesehatan lain melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesimbangan (on going professional practice evaluationon), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused professional practice).

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan standar dan evaluasi pelayanan penunjang.
- b. Untuk melakukan perbaikan pelayanan penunjang sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan tenaga kesehatan lain.

1.3 DEFINISI

Sub komite mutu profesi adalah sebuah kelompok atau organisasi yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjaga mutu profesi tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai tujuan dalam hal perlindungan, memberikan keputusan yang adil, mencegah kejadian yang tidak diharapkan dan perlindungan, memastikan kualitas asuhan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar dan prosedur.

1.4 RUANG LINGKUP

Kualitas pelayanan penunjang yang diberikan oleh staf tenaga kesehatan lain sangat ditentukan oleh semua aspek kompetensi staf tenaga kesehatan lain dalam melakukan penatalaksanaan asuhan tenaga kesehatan lain tergantung pada upaya staf tenaga kesehatan lain memelihara kompetensi seoptimal mungkin. Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui:

- a. Memantau kualitas, misalnya morning report , kasus sulit, operan jaga, audit tenaga kesehatan lain, journal reading.
- b. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat (short course), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

BAB II

TATA LAKSANA

Direktur RS Prima Husada Malang menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh mekanisme kerja Sub Komite Mutu Profesi berdasarkan masukan komite tenaga kesehatan lain. Selain itu direktur RS Prima Husada Malang bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.

2.1 Audit Tenaga Kesehatan Lain dalam peraturan perundang-undangan

Dalam peraturan perundang - undangan tentang perumah sakitan, pelaksanaan audit tenaga kesehatan lain dilaksanakan sebagai implementasi fungsi manajemen klinis dalam rangka penerapan tata kelola klinis yang baik di RS Prima Husada Malang. Audit tenaga kesehatan lain tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf tenaga kesehatan lain dalam satu kasus. Dalam hal terdapat laporan kejadian dengan dugaan kelalaian seorang staf tenaga kesehatan lain, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme disiplin profesi, bukannya mekanisme audit tenaga kesehatan lain. Audit tenaga kesehatan lain dilakukan dengan mengedepankan respek terhadap semua staf tenaga kesehatan lain (no blaming culture) dengan cara tidak menyebutkan nama (nonaming), tidak mempersalahkan (no blaming), dan tidak mempermalukan (no shaming). Audit Tenaga Kesehatan lain yang dilakukan oleh rumah sakit adalah untuk evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari (peer group) yang terdiri dari kegiatan peer-review ,surveillance dan assessment terhadap pelayanan penunjang di RS Prima Husada Malang. Panitia tenaga kesehatan lain atau masing-masing kelompok staf tenaga kesehatan lain dapat menyelenggarakan evaluasi kinerja profesi yang terfokus (focused profesional practice evaluation).

Secara umum, pelaksanaan audit tenaga kesehatan lain harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting, yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing masing staf tenaga kesehatan lain pemberi pelayanan di RS Prima Husada Malang
- b. Sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai kompetensi yang dimiliki
- c. Sebagai dasar bagi panitia tenaga kesehatan lain dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (clinical privilege)
- d. Sebagai dasar bagi panitia tenaga kesehatan lain dalam merekomendasikan perubahan atau modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf tenaga kesehatan lain

Audit tenaga Kesehatan lain dapat pula diselenggarakan dengan melakukan evaluasi berkesinambungan (on-going professional practice evaluation), baik secara perorangan maupun kelompok tentang prosedur atau tindakan tertentu (misalnya: penggunaan antibiotik, BMP pada pemeriksaan Laboratorium dan IVP pada Pemeriksaan Radiologi), dan lain – lain. Pemilihan topik ini sangat penting, dalam memilih topik agar memperhatikan jumlah kasus atau epidemiologi penyakit yang ada di RS Prima Husada Malang dan adanya keinginan untuk melakukan perbaikan. Sebagai contoh di RS Prima Husada Malang kasus Diabetes Mellitus cukup banyak dengan angka kematian cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadi masalah dan ingin dilakukan perbaikan. Langkah – langkah perbaikan meliputi:

- a. Pemilihan dan penetapan topik masalah
Topik masalah yang ingin dilakukan audit dipilih berdasarkan kesepakatan panitia tenaga kesehatan lain dan kelompok staf tenaga kesehatan lain

- b. Penetapan standar dan kriteria
Setelah topik dipilih maka perlu ditentukan kriteria atau standar profesi yang jelas, obyektif dan rinci terkait dengan topik tersebut. Misalnya topik yang dipilih diabetes mellitus maka perlu ditetapkan prosedur pemeriksaan, diagnosis, cara pemberian obat dan pemeriksaan gula darah berkala pengobatan diabetes mellitus. Penetapan standar dan prosedur ini oleh mitra bestari (peer group) dan/atau dengan ikatan profesi setempat. Ada dua level standar dan kriteria yaitu must do yang merupakan absolut minimum kriteria dan should do yang merupakan tambahan kriteria yang merupakan hasil penelitian yang berbasis bukti
- c. Penetapan jumlah kasus atau sampel yang diaudit dalam mengambil sampel bisa dengan menggunakan metode pengambilan sampel tetapi bisa juga dengan cara sederhana yaitu menetapkan kasus diabetes mellitus yang akan diaudit dalam kurun waktu tertentu, misalnya dari bulan Januari sampai Maret. Misalnya selama 3 bulan tersebut ada 90 kasus maka 90 kasus tersebut yang akan dilakukan audit
- d. Membandingkan standar atau kriteria dengan pelaksanaan pelayanan.
Subkomite mutu profesi atau tim pelaksana audit tenaga kesehatan lain mempelajari rekam medis untuk mengetahui apakah kriteria atau standar dan prosedur yang telah ditetapkan tadi telah dilaksanakan atau telah dicapai dalam masalah atau kasus-kasus yang dipelajari. Data tentang kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria atau standar maka 10 kasus tersebut agar dipisahkan dan dikumpulkan
- e. Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai dengan kriteria.
Subkomite mutu profesi atau tim pelaksana audit medis menyerahkan ke 10 kasus tersebut pada mitra bestari (peer group) untuk dinilai lebih lanjut. Kasus - kasus tersebut dianalisis dan didiskusikan apa kemungkinan penyebabnya dan mengapa terjadi ketidak sesuaian dengan standar. Hasilnya: bisa jadi terdapat "acceptable" karena penyulit atau komplikasi yang tak diduga sebelumnya (unforeseen). Kelompok ini disebut deviasi (yang acceptable). Sisanya yang 5 kasus adalah deviasi yang unacceptable, dan hal ini dikatakan sebagai "defisiensi". Untuk melakukan analisis kasus tersebut apabila diperlukan dapat mengundang konsultan tamu atau pakar dari luar, yang biasanya dari penanggulangan, mengadakan program pendidikan dan latihan, penyusunan dan perbaikan prosedur yang ada dan lain sebagainya.
- f. Rencana Audit
Mempelajari lagi topik yang sama di waktu kemudian, misalnya setelah 6 (enam) bulan kemudian. Tujuan re-audit dilaksanakan adalah untuk mengetahui apakah sudah ada upaya perbaikan. Hal ini bukan berarti topik audit adalah sama terus menerus, audit yang dilakukan 6 (enam) bulan kemudian ini lebih untuk melihat upaya perbaikan. Namun sambil melihat upaya perbaikan ini, Subkomite mutu profesi atau tim pelaksana audit dan mitra bestari (peer group) dapat memilih topik yang lain

2.2 Merekomendasikan Pendidikan berkelanjutan bagi staf Tenaga Kesehatan Lain

- a. Subkomite mutu profesi menentukan pertemuan – pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf tenaga kesehatan lain dengan pengaturan - pengaturan waktu yang disesuaikan.
- b. Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus dalam pelayanan penunjang.
- c. Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi.

-
- d. Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip dari subkomite mutu profesi.
 - e. Subkomite mutu profesi bersama - sama dengan kelompok staf tenaga kesehatan lain menentukan kegiatan – kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh subkomite mutu profesi yang melibatkan staf tenaga kesehatan lain RS Prima Husada Malang sebagai narasumber dan peserta aktif.
 - f. Setiap kelompok staf tenaga kesehatan lain wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan subkomite mutu profesi pertahun.
 - g. Subkomite mutu profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian RS Prima Husada Malang memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi.
 - h. Subkomite mutu profesi menentukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf tenaga kesehatan lain setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya.
 - i. Subkomite mutu profesi memberikan persetujuan terhadap permintaan staf tenaga kesehatan lain sebagai asupan kepada direksi.

2.3 Memfasilitasi Proses Pendampingan (Proctoring) bagi Staf Tenaga Kesehatan lain yang Membutuhkan;

- a. Subkomite mutu profesi menentukan nama staf tenaga kesehatan lain yang akan mendampingi staf tenaga kesehatan lain yang sedang mengalami sanksi disiplin atau mendapatkan pengurangan Clinical privilege.
- b. Panitia tenaga kesehatan lain berkoordinasi dengan direktur RS Prima Husada Malang.

BAB III

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi berkas Tenaga Kesehatan Lainnya (Profesional Lain) disimpan dalam arsip kepegawaian.
2. Daftar hadir disetiap kegiatan Sub Komite Mutu Profesional Lainnya.
3. Monitoring pelaksanaan dan kepatuhan para nakes lain terhadap mutu
4. Evaluasi pada tiap triwulan

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Panduan Mutu Tenaga Kesehatan Lain RS Prima Husada Malang. Panduan Mutu Tenaga Kesehatan Lain merupakan panduan pertama yang diterbitkan guna meningkatkan pelayanan di RS Prima Husada Malang. Karena itu penyusun menyadari akan banyak kekurangan terhadap panduan ini. Untuk itu perbaikan penyempurnaan akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan keadaan. Dengan adanya panduan mutu tenaga kesehatan lain ini diharapkan agar segenap karyawan RS Prima Husada Malang bisa mendapat panduan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 11 Februari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes